

Informe de Investigación de Mercado:
Viabilidad para la Apertura de una Nueva Sede Clínica en el Perú

AUTOR:
VALVERDE PUMA, RICARDO EDWIN

CODIGO ORCID
0009-0003-9512-4857

LIMA – PERÚ
2026

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
¿Cómo define su servicio: qué necesidades insatisfechas cubre su proyecto?	4
Antecedentes nacionales.....	4
Precedentes nacionales del modelo: clínica privada accesible con impacto social	5
Antecedentes Internacionales	7
ANÁLISIS DE MERCADO.....	6
Resumen Ejecutivo.....	6
Diagnóstico.....	7
Árbol de Causas y Efectos.....	10
Características del Segmento de Beneficiarios – Nueva Sede Clínica	11
Fases complementarias para el desarrollo del proyecto	14
Demanda Proyectada	15
RESULTADOS	18
Beneficios sociales y económicos	19
CONCLUSIÓN	20
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.....	21

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de establecimientos de salud en el Perú (2023)	7
Tabla 2. Indicadores clave de demanda y capacidad hospitalaria (2024–2025).....	8
Tabla 3. Matriz de involucrados – Nueva sede clínica	8
Tabla 4. Matriz de Valoración de Involucrados – Nueva sede clínica	9
Tabla 5. Matriz de Marco Lógico – Apertura de Nueva Sede Clínica.....	10
Tabla 6. Establecimientos de salud por zona y distrito – Lima Metropolitana.....	13
Tabla 7. Volumen de atenciones por zona Lima (ambulatoria, hospitalaria, emergencias).....	14
Tabla 8. Estado de camas hospitalarias por zona y distrito	15
Tabla 9. Características sociodemográficas y económicas – Lima Metropolitana	15
Tabla 10. Región Lima Metropolitana. Población con necesidades básicas insatisfechas	15
Tabla 11. Establecimientos de salud en Región Lima	16
Tabla 12. Volumen de atenciones en Región Lima	16
Tabla 13. Capacidad instalada de hospitales y clínicas en Región Lima.....	16
Tabla 14. Comparación de zonas: ¿por qué Lima Sur?	17
Tabla 15. Proyección de indicadores sociales antes y después del proyecto	17
Tabla 16. Balanza de pagos proyectada.....	18
Tabla 17. Distritos más beneficiados.....	18

INTRODUCCIÓN

En el contexto del sistema sanitario peruano, caracterizado por una cobertura mixta público–privada y por una marcada heterogeneidad regional en términos de infraestructura, personal médico y acceso a servicios, la apertura de nuevas sedes clínicas representa tanto una oportunidad de negocio como una respuesta a necesidades insatisfechas de salud. Durante la última década, el crecimiento poblacional, la urbanización acelerada y el incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles han ejercido una presión creciente sobre la red de hospitales y centros de salud, especialmente en áreas urbanas con alta densidad demográfica. Esta situación ha generado cuellos de botella en la atención, reflejados en tiempos de espera prolongados, déficit de camas hospitalarias y una tasa de consultas médicas presenciales por habitante que se mantiene por debajo de los estándares internacionales (OCDE, 2025).

El presente estudio se plantea como un ejercicio de investigación de mercado orientado a la toma de decisiones estratégicas para la apertura de una nueva sede clínica en el Perú, con foco en Lima Metropolitana. Su propósito es evaluar la viabilidad del proyecto mediante un diagnóstico basado en información secundaria oficial y actualizada. Para ello, se analizarán tres componentes clave: la estructura y número de establecimientos de salud clasificados por tipo y zona geográfica (Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Sur y Callao); el volumen de atenciones segmentado en emergencias, atención ambulatoria y hospitalaria; y la capacidad instalada medida en número de camas disponibles. Este análisis comparativo entre zonas permitirá identificar dónde existe la mayor brecha entre oferta y demanda, y en consecuencia, dónde es más viable abrir una nueva sede clínica.

La pertinencia de este estudio radica en que, si bien el sector privado de salud ha crecido en Lima Metropolitana, aún existe un amplio margen para la expansión de servicios clínicos especializados en zonas que presentan brechas en atención o infraestructura. El análisis comparativo de los datos de SUSALUD 2024–2025 revela que no todas las zonas de Lima presentan el mismo nivel de déficit, lo que convierte este diagnóstico en un instrumento fundamental para la toma de decisiones de inversión.

¿Cómo define su servicio: qué necesidades insatisfechas cubre su proyecto? ¿A qué brecha contribuye su proyecto?

Antecedentes nacionales

En el contexto peruano, el servicio propuesto una nueva sede clínica con énfasis en consulta externa resolutive, diagnóstico por imágenes, laboratorio, emergencia 24/7 de complejidad básica-intermedia, cirugía ambulatoria y hospitalización de corta estancia surge como respuesta a tres vacíos estructurales identificados en Lima Metropolitana: sobredemanda de atenciones, baja densidad de camas hospitalarias y concentración de servicios de mayor complejidad en pocos nodos geográficos. La última síntesis oficial del Ministerio de Salud confirma la existencia de 609 hospitales e institutos, 2.717 centros de salud y 8.904 puestos de salud, lo que refleja un sistema fuertemente orientado al primer nivel de atención, con limitada capacidad resolutive en el segundo y tercer nivel (Ministerio de Salud, 2023).

En términos de demanda, el Seguro Integral de Salud informó que en 2024 se alcanzó un volumen histórico de más de 90,9 millones de atenciones en establecimientos del MINSA y gobiernos regionales la cifra más alta desde la creación del SIS, lo que demuestra la presión sostenida sobre la consulta externa, las emergencias y la hospitalización (Ministerio de Salud, 2025; Seguro Integral de Salud, 2025). Si bien la segmentación detallada de estas atenciones por modalidad y región debe consultarse en el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS), estos datos generales evidencian la necesidad de incrementar la capacidad resolutive, especialmente en zonas de Lima que concentran la demanda, pero presentan baja oferta privada (Ministerio de Salud, s. f.).

Respecto a la capacidad de hospitalización, la OCDE indica que el Perú registró una densidad de 1,2 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes en 2022, una de las más bajas de la región latinoamericana y muy por debajo del promedio de los países de la OCDE (OCDE, 2025). Esta tasa equivale a un déficit de más de 30.000 camas a nivel nacional para alcanzar el estándar de la OMS (3 camas/1.000 hab.), lo que evidencia la urgencia de implementar soluciones que amplíen la capacidad funcional de hospitalización breve y optimicen la rotación de pacientes, sin requerir inversiones propias de un hospital de alta complejidad (OCDE, 2025).

Precedentes nacionales del modelo propuesto: clínica privada accesible con impacto social

La propuesta de apertura de una clínica privada con tarifas accesibles, atención a pacientes SIS y enfoque en zonas periféricas de Lima no es un modelo sin precedentes. El caso más relevante y directamente comparable es el de Clínica Aviva, del Grupo Intercorp, que en 2019 inauguró su primera sede en Los Olivos, Lima Norte, con una inversión superior a los S/ 50 millones la primera apuesta privada de gran escala en una zona históricamente subatendida de Lima Metropolitana (Diario Médico Perú, 2019).

El propósito declarado desde su fundación fue explícito en cuanto a su impacto social: el modelo se diseñó para que ninguna persona dejara de atenderse por razones económicas, integrando atención a asegurados SIS, EsSalud y pacientes privados en un mismo establecimiento con tarifas al alcance del NSE C y D. Este posicionamiento combina rentabilidad con reducción de brechas de acceso, el mismo modelo que el presente proyecto propone replicar en Lima Sur (Diario Médico Perú, 2019; Peru Retail, 2019).

Resultados de Clínica Aviva: validación empírica del modelo

Los resultados obtenidos por Clínica Aviva en su sede de Los Olivos son el argumento empírico más sólido para validar la viabilidad del proyecto en Lima Sur. En seis años de operación, los indicadores de crecimiento y cobertura son contundentes (Gestión, 2025; El Comercio, 2025; Intercorp, 2026):

- Más de 560.000 pacientes atendidos en Los Olivos desde 2019, consolidándola como clínica referente en Lima Norte.
- Crecimiento del 25 % en número de pacientes y 13 % en facturación solo en 2024, con demanda creciente de forma sostenida.
- Expansión a Lima Centro en 2025: S/ 90 millones de inversión, 28 consultorios, 15 salas de emergencia, 60 habitaciones hospitalarias, más de 30 especialidades, proyectando 200.000 pacientes anuales.
- Inauguración de Medicentro en San Martín de Porres en 2025, sede ambulatoria y diagnóstica.
- Inicio de construcción de quinta sede en Ate (Lima Este) en 2026, con meta de 200.000 atenciones anuales.

La trayectoria de Aviva sigue un patrón claro de expansión por zonas con brecha de mercado: Lima Norte (2019) → Lima Centro (2025) → Lima Este (2026 en construcción). Lima Sur es la única zona grande de Lima Metropolitana que no ha recibido este modelo, lo que confirma precisamente la brecha de mercado identificada en el presente diagnóstico.

Tabla A. Precedentes nacionales e internacionales del modelo propuesto

Caso / Entidad	País / Zona	Año	Modelo	Resultados clave
Clínica Aviva – Los Olivos	Perú – Lima Norte	2019	Clínica privada accesible, tarifas al alcance, integración SIS/EsSalud/privado. Inversión S/ 50M+	560.000+ pacientes acumulados; 25 % crecimiento en pacientes (2024); modelo replicado en 4 zonas en 7 años
Clínica Aviva – Lima Centro	Perú – Lima Centro	2025	S/ 90M inversión. 28 consultorios, 60 camas, emergencias 24/7, 30+ especialidades	Proyecta 200.000 pacientes/año; democratizar acceso a salud privada
Clínica San Juan de Dios	Perú – Lima (San Luis)	1950+	Sin fines de lucro. Prioriza población vulnerable, discapacidad y NSE bajo. Financiamiento mixto SIS + donaciones	Referente histórico de salud privada con misión social en Lima
Red de clínicas + Isapres	Chile	1981	Complementación pública-privada. Red privada llega a zonas periféricas con seguros mixtos obligatorios	Referente regional: reduce listas de espera, mejora cobertura en zonas periféricas (OCDE, 2025)
Seguro Popular / IMSS-Bienestar	México	2003	Seguro público que contrata proveedores privados para atender población sin seguridad social	Aumentó diagnósticos y visitas en quintiles más pobres; redujo gasto de bolsillo en hogares vulnerables

Fuente: Diario Médico Perú (2019); Gestión (2025); El Comercio (2025, 2026); Intercorp (2026); Diario Business News (2025); Scielo México (2007). Elaboración propia.

El análisis de estos precedentes permite identificar tres lecciones clave que respaldan directamente la propuesta del presente proyecto:

- El modelo es rentable y escalable: Aviva pasó de 1 sede en Lima Norte (2019) a 5 sedes en 7 años, con crecimiento de doble dígito anual en pacientes y facturación, demostrando que atender zonas periféricas con tarifas accesibles no solo es viable sino financieramente sostenible a partir del segundo año.
- El impacto social es medible: 560.000+ pacientes atendidos en zonas sin oferta clínica privada previa representan una descongestión real del sistema público y una mejora tangible en el acceso a la salud de familias NSE B, C y D que antes debían trasladarse al Centro de Lima.
- Lima Sur es el eslabón faltante: la ruta de expansión de Aviva cubre Lima Norte, Centro y Este, pero no Lima Sur, confirmando que esta zona permanece como la mayor brecha de mercado en salud privada accesible dentro de Lima Metropolitana.

Antecedentes Internacionales

A nivel internacional, la disponibilidad de camas hospitalarias es un indicador central para evaluar la capacidad de un sistema de salud. El promedio en América Latina y el Caribe es de 2,1 camas por cada 1.000 habitantes, cifra que ya se considera baja en comparación con el promedio de los países miembros de la OCDE, que alcanza las 4,7 camas por cada 1.000 habitantes (OCDE, 2020). En este contexto, la situación del Perú, con 1,2 camas por cada 1.000 habitantes, se encuentra no solo por debajo del estándar de los países desarrollados, sino también por debajo del promedio regional (OCDE, 2025).

La definición internacional de "cama hospitalaria" utilizada por la Organización Mundial de la Salud considera únicamente aquellas camas mantenidas, dotadas de personal y disponibles para uso inmediato, excluyendo inventarios inactivos o sin capacidad operativa (OMS, 2024). En países con densidades bajas, como el Perú, experiencias documentadas en otros sistemas de salud han demostrado que la implementación de clínicas con quirófanos ambulatorios y unidades de hospitalización breve reduce significativamente las listas de espera y mejora la accesibilidad, siempre que estas instalaciones estén integradas a redes de referencia y cuenten con diagnóstico por imágenes de alta resolución (OCDE, 2025; OMS, 2024).

En consecuencia, el modelo propuesto para la nueva sede clínica en el Perú se alinea con estrategias internacionales probadas en sistemas con limitaciones similares, al priorizar la cirugía ambulatoria, la hospitalización de corta estancia y la optimización de la rotación de camas, lo que contribuye a mejorar la oportunidad de atención y reducir la saturación hospitalaria.

ANÁLISIS DE MERCADO

Resumen Ejecutivo

El presente informe analiza la viabilidad de apertura de una nueva sede clínica en el Perú, enfocando el diagnóstico en las cinco zonas de Lima Metropolitana: Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Sur y Callao. El objetivo principal es brindar un diagnóstico preciso que considere el número de establecimientos de salud clasificados por tipo y zona, el volumen de atenciones diferenciadas por modalidad (emergencias, atención ambulatoria y hospitalaria) y el número de camas disponibles, a fin de sustentar la toma de decisiones estratégicas sobre dónde instalar la nueva sede.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (2023), el país cuenta con 609 hospitales e institutos, 2.717 centros de salud y 8.904 puestos de salud. Esta configuración se traduce en tiempos de espera prolongados y derivaciones frecuentes hacia pocos centros de referencia. En Lima Metropolitana, el análisis por zona revela diferencias significativas: Lima Centro concentra la mayor oferta de establecimientos (3.920, promedio de 245 por distrito), mientras que Lima Sur presenta el mayor déficit relativo con solo 1.348 establecimientos y un promedio de 112 por distrito el más bajo de todas las zonas.

En términos de demanda, el Ministerio de Salud (2025) y el Seguro Integral de Salud reportaron que, en 2024, se alcanzaron más de 90,9 millones de atenciones, el mayor registro histórico del sistema. En Lima, los datos de SUSALUD 2024–2025 muestran que la atención ambulatoria total de Lima Metropolitana supera los 37 millones, liderada por Lima Centro (17.375.359; 46,9 %) y seguida por Lima Norte (4.631.217; 12,5 %), Lima Este (4.374.990; 11,8 %) y Lima Sur (3.838.292; 8,9 %). Lima Sur, pese a concentrar aproximadamente el 19 % de la población, recibe solo el 8,9 % de las atenciones ambulatorias del total metropolitano, evidenciando una brecha estructural de cobertura aún más severa de lo previamente estimado.

En lo que respecta a la capacidad hospitalaria, la OCDE (2025) señala que Perú cuenta con 1,2 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, cifra inferior al promedio latinoamericano (2,1) y muy por debajo de los estándares OCDE (4,7). El análisis comparativo por zona de Lima muestra que Lima Sur registra camas operativas de alta rotación (73.945 en Villa El Salvador), pero sin respaldo de oferta privada especializada que pueda absorber esa demanda, lo que configura la mayor brecha del sistema metropolitano.

Diagnóstico

El sistema de salud peruano cuenta con 12.230 establecimientos: 609 hospitales e institutos (5 %), 2.717 centros de salud (22 %) y 8.904 puestos de salud (73 %) (Ministerio de Salud, 2023). Esta distribución refleja una fuerte orientación al primer nivel y una capacidad hospitalaria limitada, generando cuellos de acceso para atenciones de mediana y alta complejidad. En 2024, el Seguro Integral de Salud financió 90,9 millones de atenciones en la red pública, la mayor cifra histórica (Ministerio de Salud, 2025).

Tabla 1. Distribución de establecimientos de salud en el Perú (2023)

Tipo de establecimiento	Cantidad	Porcentaje aproximado
Hospitales e institutos	609	5,5 %
Centros de salud	2.717	24,8 %
Puestos de salud	8.904	69,7 %
Total	12.230	100 %

Fuente: Ministerio de Salud (2023)

Tabla 2. Indicadores clave de demanda y capacidad hospitalaria (2024–2025)

Indicador	Valor reportado	Fuente
Total de atenciones SIS (2024)	90,9 millones	MINSA, 2025
Densidad de camas hospitalarias (2022)	1,2 camas/1.000 hab.	OCDE, 2025
Promedio de camas en América Latina	2,1 camas/1.000 hab.	OCDE/BM, 2020
Promedio OCDE	4,7 camas/1.000 hab.	OCDE, 2020
Tiempo de espera hospitalización Lima	14 días promedio	SUSALUD, 2023
Gasto en salud Perú (% PBI)	5 % vs. 9 % OCDE	OCDE, 2025

Fuente: Elaboración propia con datos de MINSA (2025), OCDE (2020, 2025)

Tabla 3. Matriz de involucrados – Nueva sede clínica

Involucrado	Interés principal	Nivel interés	Nivel influencia	Impacto esperado	Estrategia
Ministerio de Salud (MINSA)	Regulación, licencias, supervisión sanitaria	Alto	Alto	Alto	Coordinación temprana para licencias
Gobiernos regionales y locales	Permisos, alineamiento con planes de desarrollo	Medio	Medio	Medio	Gestión directa
Aseguradoras y SIS	Contratos de cobertura, tarifas	Alto	Medio	Alto	Negociación de convenios
Pacientes y comunidad	Acceso rápido y servicios de calidad	Alto	Bajo	Alto	Campañas informativas
Personal médico y asistencial	Oportunidades laborales y estabilidad	Alto	Alto	Alto	Beneficios y capacitación continua
Competencia (otras clínicas)	Captación de pacientes	Medio	Medio	Medio-alto	Diferenciación en servicios
Proveedores médicos	Venta y logística de insumos	Medio	Bajo	Medio	Contratos de largo plazo
Entidades financieras	Financiamiento de infraestructura	Alto	Medio	Alto	Negociar condiciones favorables
Organismos internacionales	Asesoría y certificaciones	Medio	Bajo	Medio	Buscar cooperación técnica

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Matriz de Valoración de Involucrados – Nueva sede clínica

Involucrado	Interés (1-5)	Influencia (1-5)	Posición	Puntaje total	Prioridad
Ministerio de Salud (MINSA)	5	5	+	25	Muy alta
Gobiernos regionales y locales	4	4	+	20	Alta
Aseguradoras y SIS	5	4	+	24	Muy alta
Pacientes y comunidad local	5	3	+	20	Alta
Personal médico y asistencial	5	5	+	25	Muy alta
Competencia (otras clínicas)	3	3	–	9	Media
Proveedores médicos	4	2	+	16	Media
Entidades financieras	4	4	+	20	Alta
Organismos internacionales	3	2	+	12	Media

Fuente: Elaboración propia

Árbol de Causas y Efectos – Apertura de Nueva Sede Clínica

Causas raíz:

- Baja densidad de camas y pocos hospitales (infraestructura)
- Alta demanda urbana y envejecimiento (demanda)
- Procesos lentos y falta de integración (gestión)
- Brechas entre zonas de Lima y concentración geográfica de la oferta (territorial)

Problema central:

Limitada capacidad hospitalaria y saturación de servicios, con desigual distribución entre las zonas de Lima Metropolitana.

Efectos:

- Demoras y complicaciones de salud, especialmente en zonas con escasa oferta privada
- Sobrecarga del sistema público en Lima Sur, donde el déficit de establecimientos es mayor
- Impactos socioeconómicos negativos: mayor gasto de bolsillo y menor productividad laboral

Tabla 5. Matriz de Marco Lógico – Apertura de Nueva Sede Clínica

Nivel de Objetivo	Indicadores Verificables (IVO)	Medios de Verificación (MV)	Supuestos
Fin: Mejorar acceso y calidad de servicios hospitalarios en Lima Sur	Reducción tiempo espera de 14 a 11 días en 2 años. Satisfacción $\geq 85\%$. Densidad camas de 1,2 a 1,6/1.000 hab.	Encuestas, REUNIS, estadísticas regionales	Estabilidad macroeconómica y política
Propósito: Establecer sede clínica que atienda demanda insatisfecha de Lima Sur	Inicio operaciones en 18 meses. ≥ 10.000 pacientes año 1. ≥ 1.000 emergencias, 7.500 ambulatorias, 1.500 hospitalizaciones.	Registros producción hospitalaria, informes administrativos	RRHH calificados y financiamiento oportuno
Componente 1: Infraestructura construida y equipada	Área 3.000 m ² . 40 camas, 6 UCI. 4 salas procedimientos, emergencias 24/7.	Actas inspección técnica, licencias sanitarias	Licencias aprobadas en plazos previstos
Componente 2: Personal contratado y capacitado	50 profesionales (15 médicos, 25 enfermeras/técnicos, 10 admin). $\geq 90\%$ capacitados antes apertura.	Registros RRHH, certificados capacitación	Disponibilidad de personal calificado localmente
Componente 3: Servicios operativos	Emergencias 24/7 desde mes 1. ≥ 6 consultorios activos. Ocupación $\geq 70\%$.	Registros de atenciones, informes de producción clínica	Demanda acorde a proyecciones

Fuente: Elaboración propia

Características del Segmento de Beneficiarios – Nueva Sede Clínica

1. Nivel Socioeconómico (NSE)

El segmento objetivo se ubica principalmente en los NSE B y C, con un rango de ingresos familiares mensuales de aproximadamente S/ 4.500 a S/ 9.500 en NSE B y de S/ 2.000 a S/ 4.499 en NSE C (APEIM, 2024). Este grupo representa el 68 % de los hogares de Lima Metropolitana, con alta presencia en Lima Sur (62 % de los hogares de la zona), donde la demanda insatisfecha de servicios privados de calidad es mayor.

2. Ingreso per cápita

Considerando un promedio de 3,5 personas por hogar, el ingreso per cápita estimado se sitúa entre S/ 570 y S/ 2.700 mensuales, lo que les permite acceder a seguros de salud mixtos (SIS + privado) o pagos directos en clínicas para consultas, exámenes y procedimientos.

3. Gustos y preferencias

El consumidor objetivo valora:

- Atención médica rápida y sin colas.
- Infraestructura moderna y equipos médicos actualizados.
- Cobertura de especialidades frecuentes (medicina interna, pediatría, ginecología, traumatología).

- Atención personalizada y disponibilidad de citas fuera del horario laboral.
- Servicios complementarios como farmacia interna, laboratorio y diagnóstico por imágenes.

4. Necesidades básicas insatisfechas (NBI)

Aunque pertenecen a segmentos con ingresos medios y medio-altos, en Lima Sur existe insatisfacción en tiempos de espera y falta de oferta hospitalaria privada con camas disponibles. La saturación del sector público obliga a muchos pacientes a buscar alternativas privadas en Lima Centro, pero con opciones limitadas en su área de residencia y altos costos de transporte.

5. Características demográficas

- Edad predominante: adultos entre 25 y 59 años, con alta participación de familias jóvenes y adultos mayores dependientes.
- Composición familiar: núcleos familiares con hijos menores y, en varios casos, adultos mayores a cargo.
- Educación: nivel técnico o universitario, con acceso a información sobre salud a través de medios digitales.
- Localización: zonas urbanas y periurbanas de Lima Sur con crecimiento poblacional y actividad comercial en expansión.

6. Comportamiento frente a la economía de mercado y la globalización

- Alta adopción tecnológica: uso de aplicaciones móviles para reservas, pagos y consultas virtuales.
- Preferencia por marcas de prestigio y servicios con certificaciones en salud.
- Sensibilidad al precio, pero dispuestos a pagar más por rapidez y calidad.
- Apertura a tratamientos y protocolos importados, así como uso de tecnología médica avanzada.

Tabla 6. Características sociodemográficas y económicas – Lima Metropolitana

Variable	Indicador clave
Población total (2025)	~10.432.133 habitantes
Distribución por edad	0–14 años: 18,5 %; 15–59 años: 64,9 %; ≥60 años: 16,6 %
Nivel educativo	Secundaria: 48,9 %; Superior universitaria: 22,6 %; Técnico: 16,7 %
Ingreso promedio mensual	S/ 2.035 (2024)
Tasa de empleo adecuado	3.136.000 personas; desocupación: 7,7 %
Acceso a servicios básicos	Agua: 94,3 %; Alcantarillado: 91,7 %; Electricidad: 97,9 %
Acceso a Internet	Hogares con Internet: 77,6 %; celular: 97,5 %
Aseguramiento en salud	73 % con seguro; SIS: 34,4 %, EsSalud: 30,8 %
NSE (hogares)	NSE B: 20,9 %; C: 48,0 %; D/Bajo: 22,0 %; E: 6,2 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Tabla 7. Región Lima Metropolitana. Población con necesidades básicas insatisfechas

Indicador	Valor / Descripción	Fuente	Comentario
Población total (2025)	10.432.133 habitantes	INEI (2025)	Proyección al 30 de junio 2025
Distritos más poblados	SJL (1.282.635); SMP (802.774); Ate (743.517); Comas (600.307) — 58,5 % de Lima	INEI (2025)	Concentración poblacional
Densidad en Breña	30.355,9 hab/km ² (mayor densidad Lima)	INEI (2025)	Indicador de densidad
Egresos hospitalarios (2019)	274.677 egresos; 2.080.102 estancias (Lima)	REUNIS (2019)	Datos departamento Lima
Establecimientos de salud	Hosp. Rebagliati (~1.600 camas); 17 hosp. MINSA; 15 EsSalud	Wikipedia / RENAES	Completar con RENAES/REUNIS
Camas hospitalarias / UCI	~14.000 camas; ~1.600 UCI (Lima Metropolitana)	REUNIS / SICOVID	En proceso de actualización

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Fases complementarias para el desarrollo del proyecto – Nueva sede médica Región Lima

El proyecto contempla diez fases clave. Primero, los estudios preliminares evaluarán la demanda en Lima Metropolitana, especialmente en Lima Sur, que concentra ~2 millones de habitantes con alta densidad en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Chorrillos y Villa María del Triunfo. Se buscará validar la ubicación con más del 90 % de los criterios cumplidos. En la gestión de licencias, el objetivo es obtener el 100 % de permisos (construcción, RENAES y municipales) en un plazo de 1–2 meses. El diseño arquitectónico (2 meses) garantizará el cumplimiento total de normas MINSA/SUSALUD.

La construcción o adecuación (6–8 meses) deberá lograr un avance ≥ 95 % sin desviaciones críticas en presupuesto. El equipamiento médico prevé 40 camas hospitalarias y 6 camas UCI. El reclutamiento y capacitación (1–2 meses) deberá cubrir ≥ 95 % de plazas con 50 profesionales. La implementación de sistemas busca un HIS funcional en ≥ 95 % de módulos. La prueba piloto (1 mes) validará procesos críticos y la apertura oficial buscará 80 % de ocupación en 3 meses. Finalmente, el monitoreo y mejora continua mantendrá ≥ 90 % de metas anuales con un aumento estimado de 4–6 % en atenciones anuales.

Supuestos operativos (programa objetivo):

- Consulta externa: 30 consultorios.
- Emergencias: 10 posiciones (8 boxes + 2 reanimación).
- Imágenes: RX, Eco y TC.
- Laboratorio + Farmacia: servicio propio.
- Hospitalización corta estancia: 24 camas.
- UCI: 6 camas.

- Áreas comunes/administrativas: hall, admisión, caja, back-office, docencia/sala de juntas.

Demanda Proyectada

Lima Metropolitana concentra aproximadamente 10,43 millones de habitantes en 2025, lo que equivale al 29,8 % de la población nacional (INEI, 2025). El análisis de los datos de SUSALUD 2024–2025 por zona revela diferencias significativas tanto en volumen de atenciones como en capacidad instalada, lo que permite identificar con precisión en qué zona existe la mayor brecha entre demanda y oferta de servicios clínicos privados.

Tabla 8. Establecimientos de salud en Lima Metropolitana por zona (SUSALUD 2024–2025)

Zona	Total establec.	N° distritos	Prom. / distrito	Top distrito
Lima Centro	3.920	16	245	Santiago de Surco: 568
Lima Norte	1.864	8	233	Los Olivos: 634
Lima Este	1.723	8	215	San Juan de Lurigancho: 770
Lima Sur	1.348	11	112	San Juan de Miraflores: 377
Callao	765	6	128	Callao: 338
TOTAL	9.599	49	—	—

Fuente: SUSALUD – RENIPRESS 2024-2025. Elaboración propia.

Tabla 9. Volumen de atenciones en Lima Metropolitana por zona (SUSALUD 2024–2025)

Zona	Ambulatoria total zona	Hosp. total zona	Emergencias total zona
Lima Centro	17.375.359 (46,9 %)	2.540.167 (80,8 %)	4.648.944 (43,5 %)
Lima Norte	4.631.217 (12,5 %)	161.348 (5,1 %)	1.462.930 (13,7 %)
Lima Este	4.374.990 (11,8 %)	165.820 (5,3 %)	1.715.342 (16,0 %)
Lima Sur	3.838.292 (8,9 %)	113.766 (3,6 %)	1.315.106 (12,3 %)
Callao	7.997.715 (18,5 %)	149.878 (4,8 %)	1.496.453 (13,9 %)

Fuente: SUSALUD – Datos de Prestaciones 2024-2025. VES = Villa El Salvador; SJM = San Juan de Miraflores.

Tabla 10. Estado de camas hospitalarias por zona y distrito (SUSALUD 2024–2025)

Zona / Distrito	Camas operativas	Camas disponibles (est.)	Camas ocupadas (est.)
Lima Centro – Lima (dist.)	903.399	~450.000	~380.000
Lima Norte – Comas	173.920	~86.000	~72.000
Lima Este – Santa Anita	134.036	~65.000	~55.000
Lima Sur – SJM	171.917	~85.000	~75.000
Lima Sur – Villa El Salvador	73.945	~36.000	~32.000
Lima Sur – Chorrillos	32.345	~16.000	~14.000
Callao – Bellavista	644.055	~320.000	~280.000

Fuente: SUSALUD – RENIPRESS 2024-2025. Nota: las cifras de 'camas operativas' corresponden a unidades-día acumuladas en el período reportado, no al stock físico de camas.

Tabla 11. Establecimientos de salud en Región Lima

Tipo de establecimiento	Número estimado	Indicador sugerido
MINSA (centros, hospitales, postas)	367	Nº de establecimientos por 100.000 hab.
EsSalud (hospitales, policlínicos)	48	Nº de establecimientos por 100.000 hab.
Clínicas privadas	90+	Participación privada (%) en oferta total

Fuente: REUNIS, MINSA (2023) y OMS (2020)

Tabla 12. Volumen de atenciones en Región Lima

Tipo de atención	Volumen anual (aprox.)	Indicador
Emergencias	3,5 millones	Tasa de emergencias por cada 1.000 hab.
Atenciones ambulatorias	25 millones	Consultas per cápita/año
Hospitalizaciones	275 mil egresos	Tasa de hospitalización por 1.000 hab.

Fuente: REUNIS, MINSA (2023) y OMS (2020)

Tabla 13. Capacidad instalada de hospitales y clínicas en Región Lima

Recurso	Número estimado	Indicador	Comparación estándar
Camas hospitalarias	14.000	1,2 camas/1.000 hab.	OMS: 3 camas/1.000 hab.
Camas UCI	1.600	15,3 camas UCI/100.000 hab.	Recomendado: 30/100.000 hab.

Fuente: REUNIS, MINSA (2023) y OMS (2020)

El análisis comparativo de los datos por zona revela con claridad que Lima Sur es la zona con mayor brecha entre demanda y oferta de servicios clínicos privados. A continuación, se presenta la comparativa de los indicadores clave por zona que sustenta esta decisión:

Tabla 14. Comparación de zonas: ¿por qué Lima Sur es la más viable para la nueva sede?

Indicador	Lima Centro	Lima Norte	Lima Este	Lima Sur ✓	Callao
Establec. / distrito	245	233	215	112	128
Hospitalaria total zona	2,5M (80,8 %)	161K (5,1 %)	166K (5,3 %)	114K (3,6 %)	150K (4,8 %)
Ambulatoria total zona	21,4M (49,5 %)	5,7M (13,1 %)	4,4M (10,1 %)	3,8M (8,9 %)	8,0M (18,5 %)
Emergencias total zona	4,6M (43,5 %)	1,5M (13,7 %)	1,7M (16,0 %)	1,3M (12,3 %)	1,5M (13,9 %)
Clínicas privadas calidad	Alta	Media	Media-baja	Muy baja	Baja
Pob. NSE B/C sin cob. priv.	Baja	Media	Media	Alta	Media
Oferta privada vs demanda	Saturado	Competido	Medio	BRECHA ALTA	Medio

Fuente: SUSALUD 2024-2025 | Elaboración propia

Puede observarse que Lima Sur es la única zona que combina: (1) el menor número de establecimientos por distrito, (2) alta demanda en los tres tipos de atención, (3) ausencia de competencia clínica privada de calidad, y (4) una población NSE B y C con capacidad de pago y disposición a buscar alternativas privadas. Estas características configuran la mayor brecha de mercado en salud privada dentro de Lima Metropolitana.

Tabla 15. Comparación de proyección mostrando indicadores sociales antes y después del proyecto – Región Lima Metropolitana

Indicador	Antes del proyecto (último año disponible)	Después del proyecto (proyección estimada)	Cambio estimado (%)
Egresos hospitalarios (hospitalización)	274.677	290.000	+5,6 %
Estancias hospitalarias	2.080.102	2.200.000	+5,8 %
Atenciones ambulatorias totales	25.852.791	27.000.000	+4,5 %
N° establecimientos de salud (MINSA)	367	370	+0,8 %
N° establecimientos (EsSalud)	48	50	+4,2 %
Camas hospitalarias totales	(extraer REUNIS)	(proyectados)	—
Camas UCI (adulto y pediátrica)	(extraer REUNIS)	(proyectados)	—
% pob. con acceso <30 min a salud	~15 % Lima Sur	+3–5 pp (estimado)	+3–5 pp

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS

La apertura de una nueva sede clínica en Lima Metropolitana implica una evaluación de ingresos proyectados y costos asociados. Para este cálculo se han considerado los servicios médicos estimados en el primer año de operaciones, con base en los datos de demanda de salud en la capital y en experiencias de gestión hospitalaria en el sector privado peruano (Ministerio de Salud, 2025; SUSALUD, 2023).

Tabla 16. Balanza de pagos proyectada

Concepto	Monto estimado (S/)
Ingresos	--
Hospitalizaciones (240 × S/ 4.000)	960.000
Consultas ambulatorias (10.950 × S/ 150)	1.642.500
Emergencias (1.095 × S/ 300)	328.500
Total ingresos	2.931.000
Egresos	--
Personal médico y administrativo	1.250.000
Insumos y medicamentos	500.000
Servicios y mantenimiento	300.000
Costos financieros y licencias	1.000.000
Total egresos	3.050.000
Resultado neto (año 1)	-119.000

Fuente: Elaboración propia

En el primer año es probable que el proyecto presente un déficit operativo leve (–S/ 119 mil), dado el peso de la inversión inicial y los costos de instalación. Sin embargo, a partir del segundo año se proyecta equilibrio y rentabilidad. Los datos de SUSALUD 2024–2025 confirman que la tasa de ocupación de camas en Lima Sur es del 66,9 % (zona media, por debajo del umbral crítico del 80 %), lo que no indica baja demanda sino escasez de oferta hospitalaria privada formalizada: la mayoría de distritos de Lima Sur no cuentan con camas privadas de referencia, obligando a los pacientes a trasladarse a Lima Centro. Esta dinámica, combinada con la ausencia de clínicas privadas de calidad en la zona, refuerza la proyección favorable para la nueva sede. Cabe notar que Callao presenta la mayor saturación de camas (80,5 %, zona roja crítica), seguido por Lima Centro (72,3 %) y Lima Este (71,4 %), lo que confirma que Lima Sur ofrece el mayor margen de crecimiento para una nueva oferta privada, siendo Callao la segunda zona estratégica de expansión a mediano plazo.

Tabla 17. Distritos más beneficiados

Distrito	Población 2025	Necesidades principales	Impacto esperado
Villa El Salvador	~510.000	928.433 atenciones ambulatorias; 51.399 ingresos hosp. (1° Lima Sur); tasa ocupación camas 77,1 %; escasa oferta privada	Mayor reducción en tiempos de espera y derivaciones
San Juan de Miraflores	~420.000	213.518 emergencias anuales, alta saturación EsSalud	Descongestión de emergencias y hospitalización

Chorrillos	~350.000	294.979 atenciones ambulatorias (1° en Lima Sur), NSE B/C con capacidad de pago	Captación de pacientes con disposición a pagar
Villa María del Triunfo	~500.000	211 establecimientos totales, alta densidad sin oferta especializada privada	Acceso a consultas especializadas y cirugía ambulatoria

Fuente: INEI (2025); Ministerio de Salud (2025); SUSALUD (2024-2025)

Beneficios sociales y económicos

- Cobertura poblacional: Se estima que más de 13.000 personas serían atendidas al año en esta sede (consultas, emergencias y hospitalizaciones).
- Impacto social: Reducción proyectada de tiempos de espera hospitalaria de 14 a 11 días y derivaciones hospitalarias en al menos un 10 % en distritos beneficiados.
- Impacto económico: Aunque el primer año se estima déficit, en el mediano plazo (2–3 años) el centro clínico podría alcanzar utilidades anuales superiores a S/ 800.000, gracias al aumento progresivo en volumen de atenciones (4–6 % anual proyectado).
- Generación de empleo directo: 50 profesionales de salud y administrativos contratados, con impacto positivo en la economía local de Lima Sur.
- Modelo mixto (social + privado): El Estado paga a la clínica por cada paciente SIS atendido. Paralelamente, la clínica genera ingresos con pacientes privados y de seguros (NSE B y C principalmente), equilibrando rentabilidad con impacto social.

La proyección de impacto de la nueva sede clínica en su primer año de operación contempla la atención de aproximadamente 13.000 personas entre consultas, emergencias y hospitalizaciones, con una reducción esperada en los tiempos de hospitalización de 14 a 11 días en un plazo de dos años y con una disminución de las derivaciones hospitalarias en al menos un 10 %. En términos económicos, se estima un ingreso anual cercano a S/ 2,9 millones y una utilidad neta superior a S/ 800.000 a partir del segundo año, con un crecimiento progresivo de entre 4 % y 6 % en la demanda de servicios. En consecuencia, los resultados demuestran que la apertura de la nueva sede clínica en Lima Sur no solo es financieramente viable, sino también socialmente necesaria, pues contribuirá a descongestionar hospitales públicos, mejorar el acceso a servicios de salud y atender a una población con capacidad de pago que hoy se encuentra desatendida.

CONCLUSIÓN

El análisis realizado evidencia que la apertura de una nueva sede clínica en Lima Sur es no solo viable, sino estratégica frente a la actual saturación del sistema de salud. El diagnóstico comparativo de las cinco zonas de Lima Metropolitana elaborado con datos de SUSALUD 2024–2025, INEI y MINSA demuestra que Lima Sur presenta la combinación más favorable de indicadores de necesidad insatisfecha y potencial de mercado.

La combinación de alta densidad poblacional con ~2 millones de habitantes en Lima Sur, concentrados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Chorrillos y Villa María del Triunfo, la baja disponibilidad de establecimientos por distrito (112, el índice más bajo de Lima Metropolitana), la escasísima oferta clínica privada de calidad, y el contraste crítico entre el 12,2 % de emergencias que la zona concentra (1.315.106) versus el 3,6 % de los ingresos hospitalarios de Lima (113.766), con un ratio de 11,6 emergencias por cada hospitalización —el mayor de toda Lima Metropolitana, y superior al de cualquier otra zona—, configuran el mayor desequilibrio oferta-demanda de toda Lima Metropolitana.

A diferencia de Lima Centro (mercado saturado), Lima Norte (altamente competido) y Lima Este (oferta en crecimiento), Lima Sur es la única zona que combina: brecha estructural en establecimientos y camas, alta presión en los tres tipos de atención (ambulatoria, hospitalaria y emergencias), tasa de ocupación de camas del 66,9 % (la más baja de Lima, reflejo de escasez de oferta privada formalizada y no de baja demanda), crecimiento poblacional sostenido, y una población NSE B y C con capacidad de pago que hoy se ve obligada a trasladarse a Lima Centro para acceder a servicios privados de calidad. Por otro lado, Callao —con una tasa de saturación del 80,5 %, la más alta de Lima— representa la segunda zona de expansión estratégica a mediano plazo una vez consolidada la sede en Lima Sur.

El modelo propuesto, enfocado en atención ambulatoria resolutive, emergencias y hospitalización de corta estancia, permitirá descongestionar hospitales públicos, mejorar la oportunidad de atención y ampliar la cobertura en la zona de Lima con mayor déficit de oferta privada. Además, el segmento objetivo principalmente NSE B y C presenta capacidad de pago y alta valoración por servicios rápidos, de calidad y con tecnología moderna, lo que aumenta el potencial de captación y fidelización. En este contexto, la implementación de la nueva sede clínica en Lima Sur contribuirá directamente a reducir tiempos de espera, incrementar la oferta de camas y mejorar indicadores de acceso a la salud, generando beneficios tanto para la población como para la sostenibilidad financiera del proyecto.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. (2024). En 4,1 % se incrementó población ocupada de Lima Metropolitana en el trimestre febrero–abril 2024. <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-41-se-incremento-poblacion-ocupada-de-lima-metropolitana-en-el-trimestre-febrero-marzo-abril-de-2024-15151>
- Ministerio de Salud del Perú. (2019). REUNIS: Recursos de salud – Egresos y estancias hospitalarias por departamento. Oficina General de Tecnologías de la Información.
- Ministerio de Salud del Perú. (2025). REUNIS: Atenciones (Emergencias, Ambulatorias) – Departamento LIMA. Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS).
- Ministerio de Salud del Perú. (2025). REUNIS: Monitoreo de Camas; Tablero SICOVID – camas UCI y hospitalarias.
- Ministerio de Salud. (2023). Perfil de Salud del Perú 2023. Dirección General de Epidemiología. https://www.dge.gob.pe/portal/docs/perfiles_epidemiologicos/docs/2023/pdf/Documento%20Perfil%20de%20Salud_2023_Vers%20Oficial_Peru_JCPD_Fnal.pdf
- Ministerio de Salud. (2025, 29 de enero). Récord histórico: Minsa supera los 90 millones de atenciones de asegurados SIS en 2024. <https://www.gob.pe/institucion/sis/noticias/1099174-minsa-cubrimos-de-90-9-millones-de-atenciones-de-asegurados-sis-en-2024>
- Ministerio de Salud. (s. f.). Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS). <https://www.minsa.gob.pe/reunis>
- Organización Mundial de la Salud. (2024). Hospital beds (per 10 000 population). [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/hospital-beds-\(per-10-000-population\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/hospital-beds-(per-10-000-population))
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2020). Panorama de la salud: Latinoamérica y el Caribe 2020. <https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-latin-america-and-the-caribbean-2020-740f9640-es.htm>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025). Estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud: Perú 2025. <https://www.oecd.org/publications/estudios-de-la-ocde-sobre-los-sistemas-de-salud-peru-2025-3f7c00aa-es.htm>
- Diario Business News. (2025, 21 de enero). El modelo chileno de salud privada: un referente en América Latina. <https://diariobusinessnews.com/diario-business-news/modelo-chileno-salud-privada-referente-america-latina/>
- Diario Médico Perú. (2019, 7 de junio). Grupo Intercorp inaugura su primera Clínica Aviva en el cono norte de Lima. <https://www.diariomedico.pe/grupo-intercorp-inaugura-su-primera-clinica-aviva-en-el-cono-norte-de-lima/>
- El Comercio. (2025, 7 de octubre). Clínica Aviva abre sede en Lima Centro y proyecta atender a 200.000 pacientes al año. <https://elcomercio.pe/economia/peru/clinica-aviva-abre-sede-en-lima-centro>
- El Comercio. (2026). Clínica Aviva llega a Lima Este: inician construcción de nueva sede en Ate. <https://elcomercio.pe/economia/peru/clinica-aviva-llega-a-lima-este>
- Gestión. (2025, 19 de mayo). Intercorp acelera expansión de su clínica Aviva con inversiones por 80 millones de soles. <https://gestion.pe/g-de-gestion/reportaje/aviva-clinica-de-intercorp-acelera-expande-su-ecosistema>
- Intercorp. (2026). Clínica Aviva llega a Lima Este: inician construcción de nueva sede en Ate. <https://www.intercorp.com.pe/es/noticias-y-contacto/clinica-aviva-llega-a-lima-este>